ICS **.***.**
C**

团体标准

T/CACM ****－20**

慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准

Diagnostic criteria for chronic prostatitis damp heat stasis syndrome

（文件类型：公示稿）

CACM标准公示稿

20**–**–**发布　　20**–**–**实施

中 华 中 医 药 学 会 发 布

目次

前言..... 1
引言..... 2
慢性前列腺炎湿热瘀滞证候诊断标准..... 3
1 范围..... 3
2 规范性引用文件..... 3
3 术语和定义..... 3
4.慢性前列腺炎湿热瘀滞证的诊断依据..... 6
附 录 A..... 7
（规范性附录）..... 7
附 录 B..... 8
（资料性附录）..... 8
附 录 C..... 9
参 考 文 献..... 10

CACM标准公示稿

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草》规定的规则起草。

本文件由中国中医科学院西苑医院提出。

本文件由中华中医药学会归口。

本文件起草单位：中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、湖北省中医院、广东省中医院、成都中医药大学附属医院、云南省中医医院、上海中医药大学附属龙华医院

本文件主要起草人：高瞻 高文喜 庞然 邵魁卿 訾明杰

本文件起草人：高瞻 高蕊 高文喜 邓跃毅 曾文彤 向松涛 庞然 张春和 邵魁卿 沈建武 訾明杰 赵阳 柯刘盼 丁家森

CACM标准公示稿

引言

缺乏客观、标准的证候诊断是制约中医药学科发展的瓶颈。证候的客观量化的诊断标准研究已逐渐成为中医证候研究发展的必然趋势。证候诊断标准的规范化、标准化及量化不仅可以更好地适应于临床实际，而且适用于科学的统计方法，可促进中医学与西医及其他学科进行交流与合作。

慢性前列腺炎是指前列腺在病原体和（或）某些非感染因素作用下，患者出现以骨盆区域疼痛或不适、排尿异常等症状为特征的一组疾病[1]。中医学将其归为“精浊”等范畴。临床上以发病缓慢、反复发作为特点[2,3]，其发病原因较多，机制复杂且多数久治不愈[4]。现代中医药方法采用辨病和辨证相结合的手段，发挥中西医学各自优势来提高疗效[5]，在辨病同时强调辨证论治[6]。在慢性前列腺炎中医辨证中，湿热瘀滞证是最常见证型[7]。对国家标准及历年相关文献进行梳理，结果显示慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准条目差异较大，未对诊断条目权重赋值，导致临床应用差异较大。这一现状制约了慢性前列腺炎中医辨证标准化，阻碍了临床、科研及中西医学科之间的学术交流和发展。证候是中医学的核心[8]，证候规范化是建立中医疗效评价体系的基石，是探索和建立现代中医方法学的前提[9]。因此，研究并制定符合临床实际的慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准意义重大。

CACM标准公示稿

慢性前列腺炎湿热瘀滞证候诊断标准

1 范围

本文件规定了慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断标准。

本文件供中医/中西医结合临床医师临床疾病证候诊断。

本文件应用于全国各级医疗机构泌尿外科、男科、生殖科和中医科，包括医院、卫生院、门诊部、卫生所（室）等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB /T10112-1999 《术语工作原则与方法》

GB/T15657-1995 《中医病证分类与代码》

3 术语和定义

3.1 慢性前列腺炎 Chronic prostatitis

慢性前列腺炎是指前列腺在病原体和（或）某些非感染因素作用下，患者出现以骨盆区域疼痛或不适、排尿异常等症状为特征的一组疾病[1]。

3.2 湿热瘀滞证 syndrome of stagnant dampness-heat

湿热蕴结，血行瘀滞，以身热口渴，头身肢体沉重刺痛，胁下痞块，小便不利，便溏不爽，舌质紫红，苔黄而腻，脉滑数或涩等为常见症的证候。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义04.652][10]

3.3 尿频 frequency

排尿次数增多的现象。即成人每日排尿次数≥8 次，或夜间排尿次数≥2 次，且平均每次排出尿量少于 200ml。

[《泌尿外科学名词（2013）》，术语及定义 01.119][11]

3.4 尿急 urgency

突发的、急迫的而且很难被延迟的尿意。严重时可造成急迫性尿失禁。

[《泌尿外科学名词（2013）》，术语及定义 01.120]

3.5 尿痛 dysuria

排尿时感到尿道疼痛的现象。疼痛一般呈烧灼、针刺样痛感。可发生在排尿初、排尿中、排尿末或排尿后。

[《泌尿外科学名词（2013）》，术语及定义 01.114]

3.6 小便灼热 Burning sensation in urine

小便时尿道有灼热感。

[《中医临床常见症状术语规范（2015）》，术语及定义 P101][12]

CAC标准公示稿

3.7 **尿后滴沥** Post micturition dribble

排尿结束后仍有少量尿液从尿道口的现象。

[《泌尿外科学名词（2013）》，术语及定义 01.124]

3.8 **尿后溢浊** turbidity after urine

小便后有浊物从尿道口溢出。

[《中医临床常见症状术语规范（2015）》，术语及定义 P103]

3.9 **排尿艰涩** difficulty urinating

排尿艰难涩痛。

[《中医临床常见症状术语规范（2015）》，术语及定义 P101]

3.10 **胀痛** distending pain

疼痛伴有发胀感。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.335]

3.11 **会阴** perineum

有狭义和广义之分。狭义的会阴仅指肛门和外生殖器之间的软组织。广义的会阴是指盆膈以下封闭小骨盆下口的全部软组织。

[《人体解剖学名词(第二版)》， 术语及定义 03.0900][13]

3.12 **腰** waist

指背部第十二肋骨以下至髂嵴以上的软组织部位。

[《中医药基本名词（2004）》，术语及定义 03.296]

3.13 **小腹** lower abdomen

下腹的中部，即脐下至耻骨毛际处。

[《中医药基本名词（2004）》，术语及定义 03.308]

3.14 **少腹** lateral lower abdomen

下腹的两侧部，即小腹两旁。

[《中医药基本名词（2004）》，术语及定义 03.309]

3.15 **睾丸** testis

男性生殖腺。位于阴囊内，左、右各一。

[《人体解剖学名词(第二版)》，术语及定义 03.0701]

3.16 **耻区** public region

下腹部位于经两侧腹股沟韧带中点所作的两个矢状面的中间区域。

[《人体解剖学名词(第二版)》，术语及定义 01.0118]

3.17 **阴囊** scrotum

阴茎与会阴间的皮肤囊袋。被中隔分为两半，每侧含有睾丸、附睾和精索的阴囊部，下垂于耻骨联合下方，两侧股上部前内侧。表面皮肤薄而柔软，带褐色，常形成皱襞。

[《人体解剖学名词(第二版)》，术语及定义 03.0799]

3.18 **下腹部** hypogastrium

通过两侧髂结节所作结节间平面以下的腹部。

[《人体解剖学名词(第二版)》，术语及定义 01.0109]

CACM标准公示稿

3.19 **肛区** anal region

两侧坐骨结节连线向后与尾骨尖围成的三角区。中央有肛管通过

[《人体解剖学名词(第二版)》，术语及定义 01.0122]

3.20 **腹股沟** inguinal region

又称“髂区”，下腹部两侧的三角形区域，其内侧界为经两侧腹股沟韧带中点所作的两个矢状面，上界为两侧髂结节所作的结节间平面，下界为腹股沟韧带。

[《人体解剖学名词(第二版)》，术语及定义 01.0116]

3.21 **舌有瘀点/斑** ecchymosis on tongue

舌上出现青色、紫色或紫黑色斑点的舌象。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.187]

3.22 **红舌** red tongue

舌体颜色鲜红的舌象。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.165]

3.23 **黄苔** yellow fur

舌苔呈黄色的舌象。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.221]

3.24 **腻苔** greasy fur

苔质颗粒细小致密，紧贴舌面，不易刮脱，并在舌的中根部较厚，边尖部较薄的舌象。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.211]

3.25 **黄腻苔** Yellow greasy fur

苔黄而腻，见 1.22 1.23

3.26 **弦脉** stringy pulse

端直而长，指下挺然，如按琴弦的脉象。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.523]

3.27 **数脉** rapid pulse

脉来急速，一息五至以上（相当于每分钟 90 次以上）

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.510]

3.28 **滑脉** slippery pulse

往来流利，应指圆滑，如盘走珠的脉象。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 04.520]

3.29 **脉弦数** stringy rapid pulse

弦脉与数脉的复合脉。

3.30 **脉滑数** slippery rapid pulse

滑脉与数脉的复合脉。

3.31 **脉弦滑** stringy slippery pulse

弦脉与滑脉的复合脉。

3.32 **阴囊潮湿** Wet scrotum

阴囊皮肤潮湿，阴囊皮肤汗多潮湿，或有渗液。

CACM标准公示稿

[《中医临床常见症状术语规范（2015）》，术语及定义 P114]

4.慢性前列腺炎湿热瘀滞证的诊断依据

4.1 慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊断依据表

指标类型	主次症	指标内容	权重分值
排尿症状	主症	1.尿频	4
		2.尿急	3
	次症	1.小便灼热	2
		2.尿后滴沥	2
		3.尿痛	1
		4.尿后溢浊	1
		5.排尿艰涩	1
疼痛或不适症状	主症	1.会阴/腰部/小腹部/少腹部	3
	次症	1.睾丸/耻区/阴囊/下腹部	2
		2.肛区/腹股沟	1
舌象	主症	1.黄腻苔	3
		2.舌有瘀点/斑	3
	次症	1.黄苔	2
		2.红舌	1
脉象	主症	1.脉弦数/脉滑数/脉弦滑	3
	次症	1.脉滑	1
其他症状	次症	1.阴囊潮湿	2

4. 2 慢性前列腺炎湿热瘀滞证的诊断原则

(1) 慢性前列腺炎湿热瘀滞证的诊断依据：

1) 主症：尿频、尿急、疼痛或不适（会阴、腰部、小腹部、少腹部）、黄腻苔、舌有瘀点、舌有瘀斑、脉弦数、脉滑数、脉弦滑；

2) 次症：小便灼热、尿后滴沥、尿痛、尿后溢浊、排尿艰涩、疼痛或不适（睾丸、耻区、阴囊、下腹部、肛区、腹股沟）、黄苔、红舌、脉滑、阴囊潮湿；

(2) 至少排尿症状（尿频、尿急）和疼痛症状（会阴/腰部/小腹部/少腹部）主症同时具备 1 条，同时具备舌象中 1 条或脉象中 1 条，或有次症 1 条及以上或无次症；

(3) 按照权重总分分级，慢性前列腺炎湿热瘀滞证证候程度轻、中、重分级如下：

（主症权重+次症权重+舌象权重+脉象权重+其他症状权重）

1) 轻 7~10 分；

2) 中 11~20 分；

3) 重 ≥21 分。

CACM标准公示稿

附 录 A
（规范性附录）
《标准》中证候术语规范

A.1湿热下注证 syndrome of dampness-heat diffusing downward

湿热之邪侵及肠道、膀胱、子宫、阴部、下肢等处，以小便频急淋漓涩痛，或大便腥臭溏烂，或带下黄臭，或阴部湿疹、瘙痒，或下肢生疮、溃烂流水等为常见症的证候。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义04.653]

A.2 气滞血瘀证 blood stasis due to qi deficiency

气机运行不畅，以致血液运行障碍，形成气滞与血瘀并存的病理变化。

[《中医药学名词（2004）》，术语及定义 03.591]

CACM标准公示稿

附 录 B
（资料性附录）
既往慢性前列腺炎湿热瘀滞证诊疗专家共识

表 B.1 慢性前列腺炎中西医结合诊疗专家共识

时间	来源	内容
2015 年	张敏建,宾彬,商学军,邓庶民,王万春,周少虎,谢建兴,高兆旺,李彦锋.慢性前列腺炎中西医结合诊疗专家共识[J].中国中西医结合杂志,2015,35(08):933-941.	主症：小便频急，灼热涩痛，排尿困难，余沥不尽，会阴胀痛或下腹、耻部、腰骶及腹股沟等部位不适或疼痛。 次症：小便黄浊，尿道滴白，口苦口干，阴囊潮湿。舌脉：舌红，苔黄腻，脉弦数或弦滑。

CACM标准公示稿

附 录 C

指南制定组成员

C.1 本指南专家指导组成员

指导委员会：张亚强 韩瑞发 谢雁鸣 张蜀武 王树声

本文件领域专家（共识）委员会：高瞻 高蕊 高文喜 曾文彤 向松涛 庞然 邵魁卿

本文件首席专家：高瞻

本文件起草组：高瞻 高蕊 高文喜 邓跃毅 曾文彤 向松涛 庞然 张春和 邵魁卿 沈建武 訾明杰 赵阳 柯刘盼 丁家森

本文件执笔人：高瞻 庞然 邵魁卿 訾明杰 丁家森

本文件参与问卷调查专家（按姓氏笔画排序）：丁才学、丁世霖、王一辰、王二朋、王传航、王伊光、王丽霞、王健明、王彬、王慎鸿、王慕华、王德林、尹静、孔涛、代宏亮、邢鲁斌、朱德元、向松涛、刘兵、刘绍明、刘辉、孙小勇、李广森、李文广、李永生、李迎杰、李炤、李焱风、李源、杨士杰、杨晨迪、杨静哲、杨毅坚、时京、吴昱晔、汪勇、沈建武、宋竖旗、张卫、张志杰、张春和、张健、张富刚、张蜀武、张磊、陈国宏、陈铭、邵魁卿、范海青、郁超、罗卫平、庞然、郑祥奇、屈淼林、屈颖伟、孟军、赵文兵、胡少炜、柏宏伟、钟嘵、袁卓珺、桂定文、贾玉森、夏雨果、徐波、高文喜、高坪、高瞻、郭凡、郭浩、郭跃先、黄克江、梅雪峰、崔崎、阎家骏、葛旻垚、董瑜、程翔、傅骏、曾凡雄、曾文彤、曾令启、曾治军、蔡剑

CACM标准公示稿

参 考 文 献

[1] 杨勇，李虹. 《泌尿外科学》[M]. 北京：人民卫生出版社，2015.

[2] 薄海，谢铮. 慢性非细菌性前列腺炎的中医诊疗策略[J]. 北京中医药，2018，37(12)：1165−1166.

[3] 彭玉平，黄卫，邢益涛，等. 宁泌泰胶囊联合左氧氟沙星治疗慢性前列腺炎的疗效观察[J].中国中西医结合外科杂志，2019，25(03)：366−369.

[4] 郑小挺，陈东，尹申，等. 前列腺液中白细胞计数对慢性前列腺炎症状程度的影响[J]. 中华中医药学刊，2016，34(08)：1914−1916.

[5] 王文健，沈自尹. 从“同病异证”到“同病类证”[J]. 中国中西医结合杂志，2014，34(01)：9−12.

[6] 莫旭威，王彬，李海松，等. 中医治疗慢性前列腺炎的思路与方法[J]. 世界中医药，2013，8(10)：1244−1247.

[7] 李海松，韩富强，李曰庆. 918 例慢性前列腺炎中医证型分布研究[J]. 北京中医药，2008(06)：416−418.

[8] 史云佳，吴斌，李延萍. 中医证候规范化进展与思考[J]. 中国中医药现代远程教育，2019，17(17)：123−125.

[9] 张志强，王燕平，张华敏，等. 证候规范化的问题及策略[J]. 现代中医临床，2016，23(06):1−3

[10] 中医药学名词审定委员会. 《中医药学名词》[M]. 北京：科学出版社，2005.

[11] 医学名词审定委员会泌尿外科学名词审定分委会. 《泌尿外科学名词》[M]. 北京：科学出版社，2014.

[12] 黎敬波，马力. 《中医临床常见症状术语规范》[M]. 北京:中国医药科技出版社，2015.

[13] 人体解剖学与组织胚胎学名词审定委员会.《人体解剖学名词》[M]. 北京：科学出版社，2014.

CACM标准公示稿

CACM标准公示稿